

Douleur au mollet

Anamnèse :

- Caractérisation de la douleur
 - Localisation : unilatéral vs bilatéral
 - Irradiation
 - Chronologie
 - Début
 - Circonstance de survenue
 - Évolution (fluctuation)
 - Intensité
 - Qualité
 - Facteurs aggravants/soulageants
- Manifestations associées
 - Rougeur
 - Œdème
 - Chaleur – froid
- **Distance de marche – claudication intermittente**
- Activité physique inhabituelle, **traumatisme**
- Autres symptômes associés
 - Dyspnée
 - Fièvre
- FR thrombo-embolique
 - Voyages récents
 - Immobilisation
 - Hospitalisation
 - Cancer
 - Grossesse
- FRCV
 - Tabac
 - HTA
 - Hypercholestérolémie
 - Diabète
 - ATCD familiaux
- Antécédent
 - Épisode similaire antérieur ?
 - Maladie
 - Hospitalisation/opération
 - Médicaments
 - Allergie
- Habitudes
 - Diète
 - Alcool
 - Tabac
 - Drogues

Examen clinique :

- Local
 - Rougeur
 - Pâleur
 - Signes de Homans
- Cardio-vasculaire
- Pulmonaire
- Neurologique

DD douleur au mollet :

- Artériel
 - Ischémie des membres inférieurs →
 - Syndrome de l'artère poplitée piégée
- Veineux
 - Thrombose veineuse profonde ou superficielle
 - Syndrome post-thrombotique
- Neurologique
 - Claudication neurogène
- Musculaire
 - Contracture- élancement
 - Courbature
 - Déchirure – rupture
 - Syndrome aigu des loges musculaires
 - Hernies myofasciales isolées
- Métabolique
 - Maladie de Paget
- Tumoral
- Infectieux
 - Dermohypodermite
 - Ostéomyélite

Les 6 P (drapeaux rouges) :

1. **Pain** → douleur, apparition brutale, de type crampe
2. **Pallor** → membre pâle en distalité, temps de recoloration > 3 sec
3. **Polar** → membre froid en distalité
4. **Pulselessness** → pouls périphériques absents (tibial postérieur et pédieux)
5. **Paresthesia** → troubles sensitifs initiaux
6. **Paralysis** → troubles moteurs dans un second temps

Ostéomyélite :

- Fièvre, frisson
- Douleur à la palpation locale

Dermohypodermite :

- Fièvre
- Rougeur, chaleur, œdème

DD claudication intermittente :

- Vasculaire
 - Thrombose (soulagé couché)
 - Artériosclérose (soulagé à l'arrêt)
- Neurogène (soulagé à croupi, penché en av., pire en descente et penché en arrière)
 - Médullaire
 - Radiculaire
- Articulaire
 - Post-traumatique
 - Arthrite

Symptoms	Neurogenic	Vascular
Quality	Pain/numbness/tingling/weakness	Pain/cramping/tightness
Increased with walking	Yes	Yes
Relieved walking flexed with a cart	Yes	No
Relieved standing erect	No	Yes
Relieved sitting/lying	Within minutes	Immediate
Increased walking uphill/upstairs	No/less	Yes
Increased walking downhill	Yes/more	Yes
Increased biking/back flexed	No	Yes
Increased biking/back extended	Yes	Yes

Examen complémentaire :

- AOMI : ABI + US
- TVP : D-dimères + US
- Claudication neurogène : IRM colonne
- Dermohypodermite : hémoc si fièvre + co-amox
- Ostéomyélite : FSC, CRP + hémocultures + imagerie (US/IRM/Rx)